

Le vertige aigu spontané: les clés du diagnostic différentiel périphérique ou central

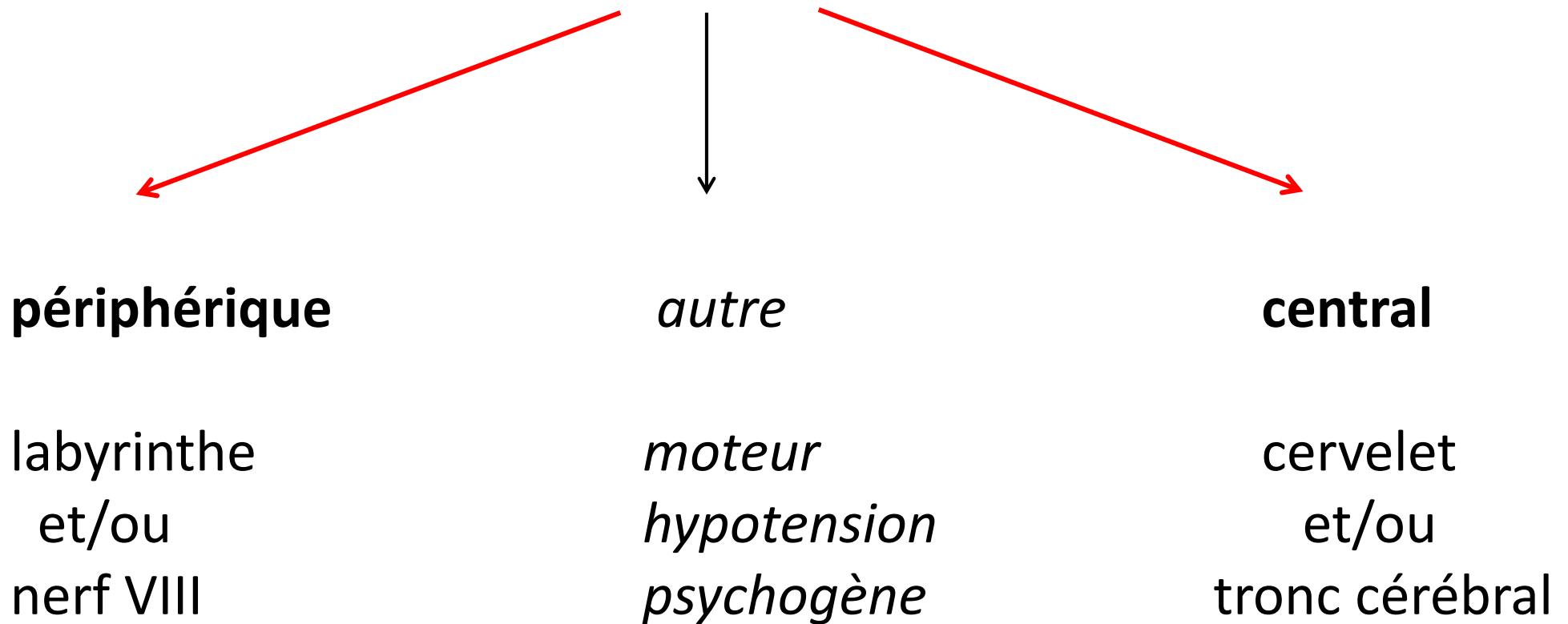
Dr Raphaël Maire, PD & MER

Service ORL, CHUV

Vertige aigu d'apparition spontanée diagnostics principaux

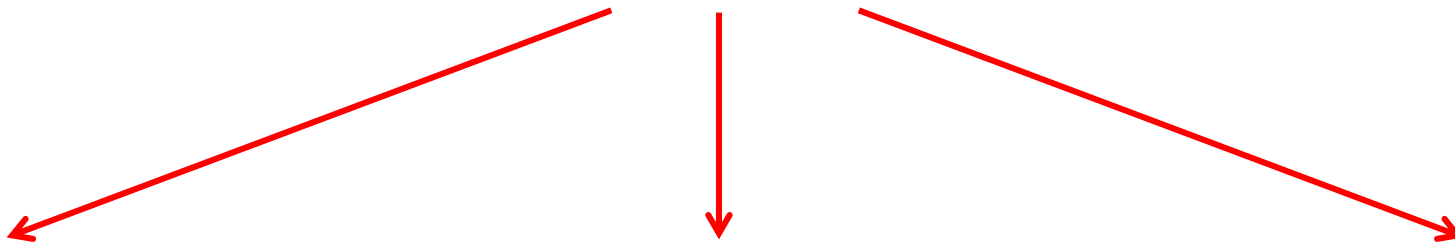
- vertige paroxystique positionnel bénin
- déficit vestibulaire périphérique unilatéral brusque
(p.ex. névrite vestibulaire)
- maladie de Menière
- AIT, AVC de la fosse postérieure
- SEP, tumeur
- Intoxication (médicaments, alcool)

vertige aigu spontané:



vertige aigu spontané

Examen neurovestibulaire



Mouvements oculaires

nystagmus? type?



Posture et extrémités

ataxie?

statique
(posture)

cinétique
(mouvements)

Autres signes

nerfs crâniens?

sensitif? moteur?

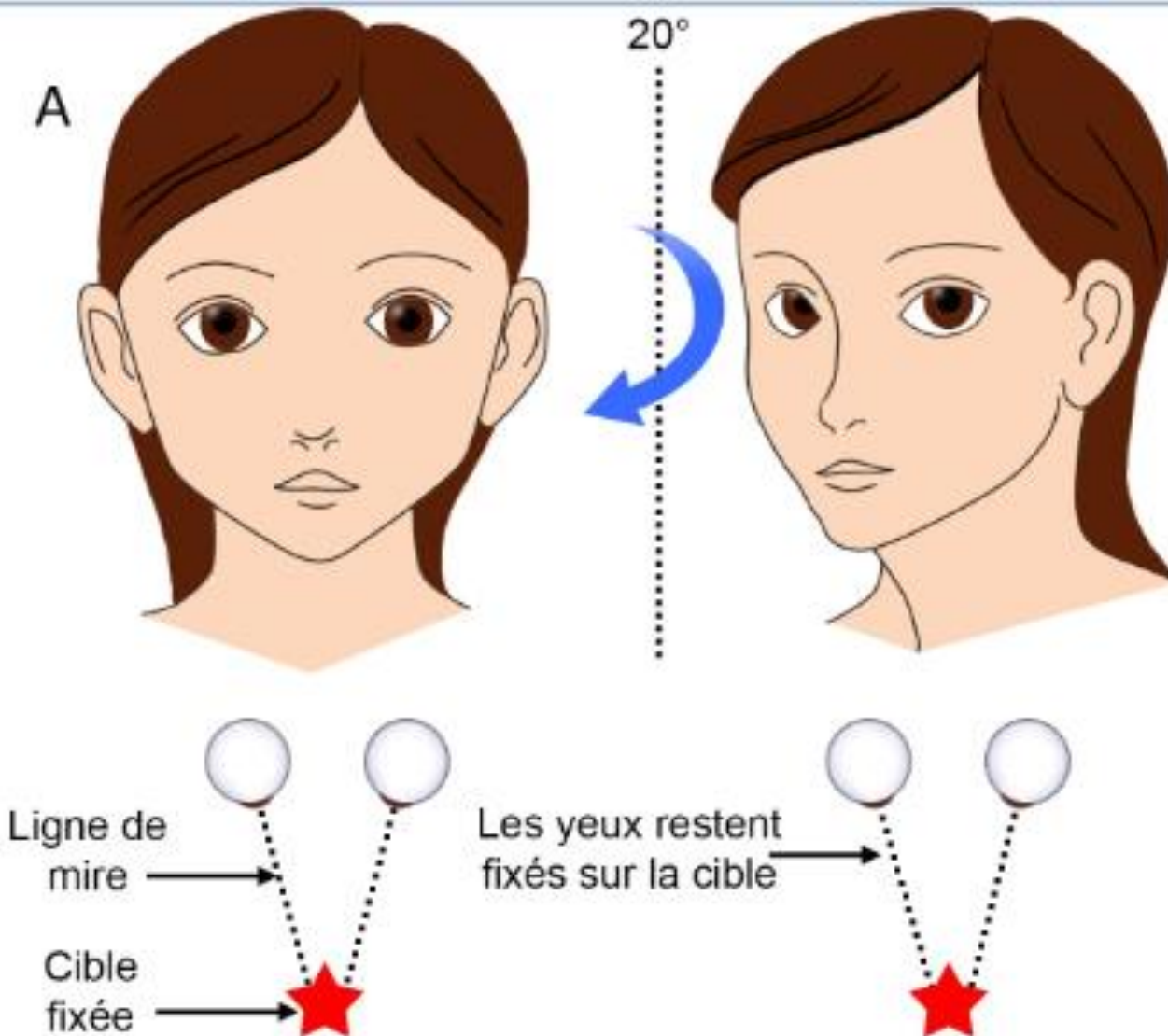
Nystagmus pathologiques

origine	caractéristiques
périphérique	conjugué (binoculaire) ↓ ou stoppé en fixation
central	conjugué / dissocié non ↓ ou ↑ en fixation

Signes d'une lésion vestibulaire périphérique (labyrinthe et/ou nerf VIII)

- nystagmus spontané conjugué (binoculaire), unidirectionnel, horizonto-rotatoire, inhibé en fixation visuelle, battant presque toujours du côté sain
- test de Halmagyi (*head impulse test*) pathologique du côté lésé
- surdité et/ou acouphène unilatéral associé
- manœuvre de Dix-Hallpike positive (vertige paroxystique positionnel bénin)
- pas de signe neurologique central

Head Impulse Test (Test de Halmagyi)



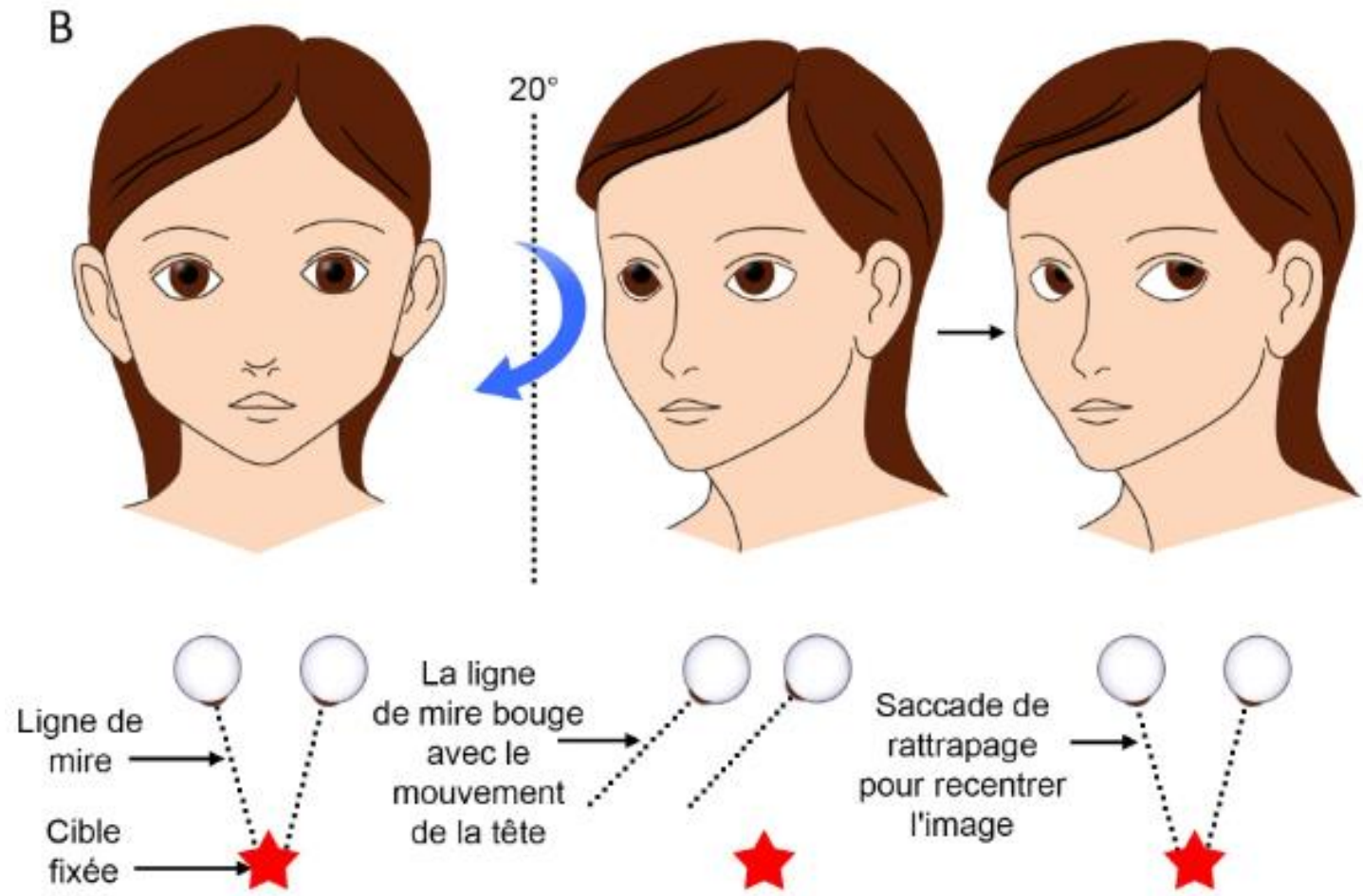
**Head Impulse
normal Etat
physiologique**

le RVO est
fonctionnel des
deux côtés et
permet de maintenir
le regard fixe sur la
cible visuelle lors du
mouvement de la
tête.

Head Impulse test pathologique (signe de Halmagyi positif)

Déficit vestibulaire canaire droit

lorsque la patiente tourne la tête à droite, elle perd la cible du regard et effectue une saccade de recentrage à la fin du mouvement (signe de Halmagyi)



Signes d'une lésion vestibulaire centrale (cervelet et/ou tronc cérébral)

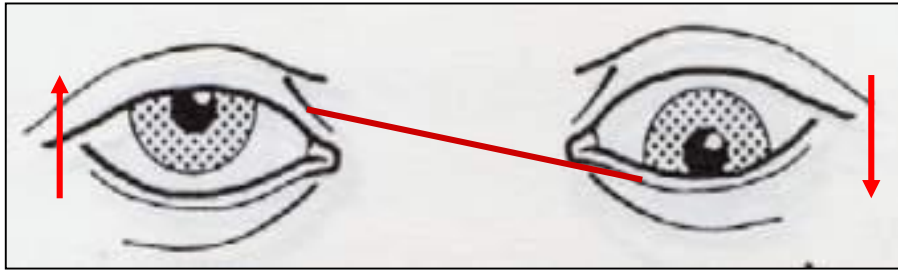
- nystagmus spontané purement horizontal, non inhibé ou augmenté en fixation visuelle
- nystagmus spontané (ou évoqué par le regard excentré) de direction changeante
- nystagmus spontané vertical (downbeat/upbeat nystagmus)
- flutter oculaire / opsoclonus
- nystagmus dissocié (ophtalmoplégie internucléaire)

Signes d'une lésion vestibulaire centrale (cervelet et/ou tronc cérébral)

- saccades oculaires hypermétriques
- strabisme vertical (*skew deviation*)
- head impulse test normal des deux côtés
- ataxie cérébelleuse (statique et/ou cinétique)
- autres symptômes ou signes d'atteinte centrale
hoquet, dysarthrie, Horner, déficit sensitif/moteur, etc.

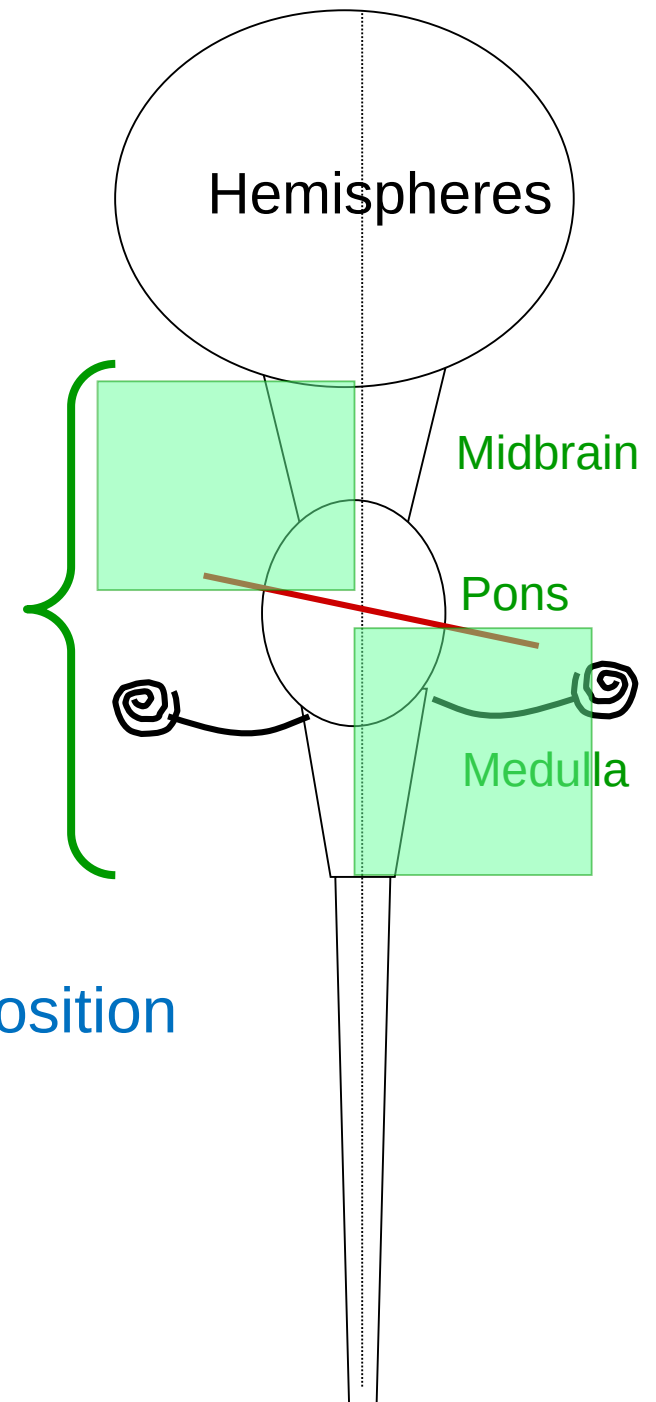
Skew deviation:

How to localize the lesion



Elevation one eye Depression other eye

1. Draw an oblique line according to eye position
2. Put this line into the mid-pons
3. Lesions are above the higher part or below the lower part of the line



Vertige aigu spontané: périphérique ou central ?

DD: labyrinthe vs AVC fosse postérieure

HINTS to Diagnose Stroke in the Acute Vestibular Syndrome: Three-Step Bedside Oculomotor Examination More Sensitive Than Early MRI Diffusion-Weighted Imaging Jorge C. Kattah et al. *Stroke* 2009

HINTS : Head Impulse – Nystagmus – Test of Skew

Head impulse Test (Halmagyi) normal des 2 côtés

+ nystagmus spontané direction changeante ou nystagmus regard excentré

+ strabisme vertical (skew deviation)



100% sensibilité et 96% spécificité
pour AVC fosse postérieure